

ПОРУШЕНА ПОЗАМАТКОВА ВАГІТНІСТЬ

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася жінка 25 років. Скарги на різкий біль унизу живота, втрату свідомості вдома, затримку менструації. Загальний стан середньої важкості, АТ 100/60 мм рт.ст., пульс 100 ухв. Шкіра та слизові бліді. Остання менструація два місяці тому. З перенесених захворювань відмічає бронхіт, ГРВІ. При бімануальному дослідженні – матка збільшена незначно, м'яка, праворуч пальпується різко болюче утворення без чітких контурів, заднє склепіння нависає, різко болюче. Виділення із статевих шляхів кров'яністі незначні. Тест на ХГЛ- позитивний. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні й етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	85
еритроцити ($10^{12}/л$)	2,9
Кольоровий показник	0,80
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	14
Лейкоцити ($10^9/л$)	8,3
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкоядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	80 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,014
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	5-6 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з
Циліндри гіалінові	немає
Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження

вільна рідина у задньому склепінні



Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог. Мене звати...
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «Скарги на різкий біль унизу живота, втрату свідомості вдома, затримку менструації»
2.2	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь: «ГРВЗ, бронхіт»
2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу?» Очікувана відповідь: «Остання менструація два місяці тому»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Загальний стан – середньої важкості. Шкіра та слизові бліді, холодний піт. Серцево-судинна система: АТ – 100/60 мм рт.ст., пульс – 100 уд./хв., слабкого наповнення. Дихальна система: без патологічних змін.

3.2	Акушерське обстеження	Сказати: матка збільшена незначно, м'яка. Праворуч пальпується різко болюче утворення без чітких контурів. Заднє склепіння нависає, різко болюче
3.3	Піхвове дослідження	Сказати: Виділення зі статевих шляхів – незначні кров'янисті.
3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе відчуваєте? » Очікувана відповідь: Задовільно
4. Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: знижені показники гемоглобіну, еритроцитів, - анемія (залізодефіцитна)
4.2	Визначити результат клінічного аналізу сечі	Сказати норма, ХГЛ- позитивний
4.3	Визначити результат ультразвукового дослідження	Сказати- вільна рідина у задньому склепінні
4.4	Визначити провідний синдром	Сказати- больовий, анемічний
4.5	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Порушена позаматкова вагітність праворуч.
15. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення вагітної	Сказати : екстрене хірургічне втручання.
16. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати - післяопераційне ведення. - Раціональне харчування (білки, залізо, вітаміни).
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані. У вашому випадку порушена позаматкова вагітність призводить до внутрішньої кровотечі, що може призвести до геморагічного шоку та загибелі. Внаслідок крововиливу у черевну порожнину можливий розвиток перитоніту При видаленні маткової труби – втрата репродуктивної функції Ризик повторної позаматкової вагітності

Сценарій.